

BRONQUITIS AGUDA

Raquel García González, Manuel Ángel Ochoa Vilor, Miriam Martínez Fernández, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La bronquitis aguda es una patología muy frecuente en los servicios de urgencias y es la causa más frecuente en la etapa de gripe estacional (invierno). Es una inflamación, normalmente autolimitada de la mucosa bronquial. La bronquitis puede ser aguda o crónica. La bronquitis aguda se produce a partir de una infección respiratoria generalmente del resfriado común. La bronquitis crónica, es una inflamación continua de la mucosa bronquial, es una enfermedad grave y se produce generalmente por fumar.

DIAGNÓSTICO

Clínica

El diagnóstico es clínico. El paciente puede presentar síntomas de resfriado, tos (productiva: esputo transparente, blanquecino hasta amarillento / verde o no productiva), sibilancias, disnea leve e incluso escalofríos, febrícula o fiebre. A la auscultación podemos encontrar roncus y sibilancias o ser normal. En pacientes ancianos o pluripatológicos puede haber formas de presentación atípicas. Generalmente el cuadro es autolimitado en 2 -3 semanas y la resolución suele ser total. Hablamos de bronquitis aguda en pacientes que no tienen patología pulmonar crónica conocida y debemos diferenciarlos de exacerbaciones o crisis de asma.

Etiología

Los microorganismos involucrados en la bronquitis aguda son:

- **Virus:** son los más frecuentes y destacan. **Frecuentes:** virus de la gripe A y B, parainfluenza, virus respiratorio sincitial, metapneumovirus. **Menos frecuentes:** adenovirus, enterovirus (echovirus y coxsackie), rinovirus, coronavirus (SARS y MERS), virus del sarampión, VHS.
- **Bacterias:** son menos frecuente y dentro de ellas: *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Bordetella pertussis*, *Bordetella holmesii*, *Bordetella bronchiseptica*.

Alerta

- En el caso concreto de la Tosferina causada por *Bordetella Pertussis* debemos sospecharla en adultos sanos si la tos se cronifica (más de 4 semanas) y además es paroxística, con estridor inspiratorio y vómitos. Es especialmente importante la información epidemiológica y ante la sospecha debemos solicitar estudio microbiológico de exudado nasofaríngeo, incluida PCR y cultivo. La Tosferina es una enfermedad de declaración obligatoria.

Pruebas complementarias

Habitualmente no son necesarias, pero si el paciente presenta:

- **Sospecha de neumonía** (taquicardia, taquipnea, disnea, hemoptisis, dolor pleurítico, fiebre alta > 38°C, estertores crepitantes, hipoventilación más o menos localizada, disminución del murmullo vesicular, aumento de las vibraciones vocales y matidez a la percusión en zona afectada: signos de consolidación en la auscultación).
- **Gran afectación clínica.**
- **Fiebre** > 38°C y escalofríos de más de 3-5 días de duración.
- Pacientes pluripatológicos / inmunodeprimidos.
- SatO₂ < 94%.

Se solicitará:

- Radiografía de tórax posteroanterior (PA) y lateral.
- Hemograma.
- Coagulación si esta anticoagulado y/o signos de sepsis.
- Bioquímica básica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR, procalcitonina.
- Gasometría arterial.
- Sistemático y sedimento de orina. Si clínica urinaria.

TRATAMIENTO

1. Medidas generales:

- Beber abundante agua.
- Abstención del tabaco.
- Humidificar el ambiente.

2. tratamiento sintomático:

- Paracetamol 1 gr cada 8h durante 3-5 días o ibuprofeno 600mg cada 8h durante 3-5 días.
- Codeína (Codeisan 1,26 mg/ml jarabe) cada 8h durante 5-7 días si tos.
- Antihistamínico: cetirizina 10mg 1 cada 24h durante 5-7 días (por las noches, produce somnolencia).
- Agonistas Beta2: Broncodilatadores si el paciente está muy afectado, especialmente si presentan signos de broncoespasmo a la auscultación:

Salbutamol (Ventolin 2 puff cada 8 horas, descendiendo cada 2 días, luego a demanda) o

Terbutalina (Terbasmin turbuhaler 500mcg/inhalación 1-2 inhalaciones cada 4- 8 horas máximo 6000 mcg/24horas en > 12 años y adultos).

Complemento al tratamiento sintomático:

- **Oseltamivir** zentiva 75 mg capsulas: 75mg cada 12h durante 5 días y 10 días en pacientes inmunocomprometidos. Eficaz cuando se inicia tratamiento en los primeros dos días de aparición de los síntomas de la gripe. Indicado en el tratamiento de la gripe, pacientes con síntomas de la gripe y cuando el virus influenza circula en la población o en situación de epidemia gripal:

Peso corporal	Pacientes adolescentes > 13 años y adultos	Pacientes inmunodeprimidos *
> 40 kg	75 mg cada 12h durante 5 días	75 mg cada 12h durante 10 días

*La duración recomendada del tratamiento en adultos y adolescentes inmunodeprimidos es de 10 días

- **Zanamivir** (Relenza 5 mg/dosis polvo para inhalación (unidosis)): 2 inhalaciones cada 12 horas durante 5 días. Indicado en el tratamiento de la gripe A y B en adultos y niños a partir de los 5 años de edad, iniciar tratamiento lo antes posible, antes de 36 horas en niños y 48 horas tras la aparición de los síntomas en adultos.

3. Tratamiento antibiótico:

No están indicados los antibióticos de forma general. Si hay sospecha de neumonía usar:

- Amoxicilina/ácido clavulánico: 875/125 mg 1 cada 8 horas durante 7 días.
- Si alergia a betalactámicos: Claritromicina 500mg cada 12 horas durante 7 días.

En caso de **estridor inspiratorio**, **vómitos desencadenados por la tos** y **tos** persistente de más de 4 semanas **con o sin paroxismo**, sospechar infección por:

a. Bordetella Pertussis está indicado el tratamiento con:

- Claritromicina 500mg cada 12 horas durante 7 días o
- Azitromicina 500mg el 1er día, luego 250mg cada 24 horas durante 4 días.
- Si sospecha de resistencia, intolerancia o alergia a macrólidos usar: Trimetroprin / sulfametoxazol 160/800 mg cada 12 horas durante 7 días

b. Mycoplasma pneumoniae y por **Chlamydia pneumoniae** está indicado el tratamiento con:

- Doxiciclina 100mg cada 12h durante 7- 10 días o
- Levofloxacino 500 mg 1 cada 24h durante 7- 10 días o
- Azitromicina 500mg el 1er día, luego 250mg cada 24 horas durante 4 días.

El uso de mucolíticos y antitusígenos no ha demostrado mejorar la historia natural de la enfermedad. Es importante comentar con el paciente la benignidad del cuadro y su carácter autolimitado en unas 2-3 semanas, informando que la tos podría persistir durante más tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias y emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 5ª Ed; Elsevier 2015
- Suarez Pita D, Vargas Romero JC, Salas Jarque J, Losada Galván I, Miguel de Campo B, Catalán Martín PM et al. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 8ª ed. Madrid: MSD; 2016.
- Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J et al. Harrison's principles of internal medicine. Vol 2. 19th ed. New York: McGraw-Hill; 2012.
- Mensa J, Soriano A, García-Sánchez J, Marco F, Letang E, Llinares P, López-Suñé E, Barberán J. Guía de Terapéutica Antimicrobiana 2020. Editorial Antares. 2020.
- Relenza: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/62712/FichaTecnica_62712.html#4-1-indicaciones-terap-uticas.
- Oseltamivir: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/85057/FT_85057.html#4-1-indicaciones-terap-uticas.